

HABILIDADES CIRÚRGICAS



MONITORIA DE TOCE

Revisão Flash • SESSÃO 09

Afecções Urológicas

O essencial para a prova em uma página



Técnica Operatória e Cirurgia Experimental
UniBH Vespasiano

8º PERÍODO • 2026.2

Elaborado por JOÃO BATISTA FERNANDES JÚNIOR • *Monitor de TOCE*

Material de apoio da monitoria. Não substitui as aulas, os slides nem as referências indicadas pela disciplina.

Afecções urológicas

Leitura de 5 minutos

EM UMA FRASE

AINE na cólica e descompressão se houver febre; sonda na retenção; escroto agudo é torção até prova em contrário; e nunca sondar com sangue no meato.

- | | |
|--|--|
| <p>1 Cólica renal: AINE é a 1ª escolha. Opióide é 2ª opção.</p> | <p>2 Imagem: TC sem contraste confirma. Gestante e criança começam pela ultrassonografia.</p> |
| <p>3 Cálculo < 5 mm no ureter distal: 89% eliminam sozinhos.</p> | <p>4 α-bloqueador: para cálculo do ureter distal > 5 mm.</p> |
| <p>5 Obstrução + febre: duplo J ou nefrostomia + antibiótico; o cálculo fica para depois.</p> | <p>6 Retenção: sondagem de alívio; se a sonda não passa, cistostomia.</p> |
| <p>7 Torção: janela de 4–6 h; o Doppler não pode atrasar a cirurgia.</p> | <p>8 Sangue no meato: não sondar; uretrografia antes.</p> |

TORÇÃO × EPIDIDIMITE

	TORÇÃO	EPIDIDIMITE
<i>Cremastérico</i>	Ausente	Presente
<i>Prehn</i>	Não alivia	Alivia
<i>Doppler</i>	Sem fluxo	Hiperfluxo

PEGADINHA

Fluxo ao Doppler **não exclui** torção. Na sondagem, só insufla o balão depois de ver urina.

CHECKLIST ANTES DA PROVA

- ☐ Sei a analgesia e a imagem da cólica renal
- ☐ Sei quando descomprimir o rim
- ☐ Sei conduzir a retenção urinária
- ☐ Sei os remédios da HPB e quando operar
- ☐ Diferencio as três causas de escroto agudo
- ☐ Separo priapismo isquêmico do não isquêmico
- ☐ Sei a técnica e as contraindicações da sondagem